

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: MARIA CAROLINA BARRIOS DAZA	H.C: 1018480153
EDAD: 29 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 26/10/1995
ESCOLARIDAD: NA	FECHA DE EVALUACIÓN: 21,23/08/2025
DIRECCION: CARRERA 13 B # 6 B - 46	CORREO: NA
EPS: Salud Total	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3053610519

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente refiere, me cuesta concentrarme, al momento de hablar me quedo en blanco, me desconcentro con facilidad.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde la niñez caracterizado por hablar mucho en clase, muy lenta para escribir, perfeccionista, hablaba mucho en clase, con altas consideraciones de liderazgo, desde la universidad con fecha aproximada del 2013, agrega que ha tomado conciencia de muchas cosas, por ejemplo ya no levanta la voz la hablar, expresa que se vio afectada debido a este señalamiento, pero que le ayudo a mejorar, en el 2020 viajo a España a realizar maestría, argumentando que comenzaron a pasar cosas que afectaron la autoestima, agrega que actualmente le cuesta retener información cuando tiene mucha presión, expresa que en el anterior empleo olvidaba las directrices, consignas, le toma más tiempo del habitual aprender, debe hacer un esfuerzo mayor que sus pares, en la universidad dejaba el trabajo para última hora, en ocasiones hacia otra cosa – evitaba, al final terminaba haciéndolo con una sensación picazón en el cuerpo, sentía como una pelota en la garganta, desesperación, tenía que volver a leer varias veces para entender. Fue diagnosticada por psiquiatría con ansiedad y depresión agosto del 2023 mientras estaba viviendo en España. Actualmente está en tratamiento por psicología clínica.

ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: NO.

Quirúrgicos: Si, hernia umbilical.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Autismo: Primo materno tercer grado.

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Alzheimer: No reporta



TDAH: No reporta

Síndrome de Down: Primo materno tercer grado.

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA CONSULTA

Paciente con adecuada presentación personal, se muestra alerta, motivada, inadecuada higiene postural, orientada auto y alopsiquicamente, lenguaje y pensamiento fluido, facies depresiva, labilidad emocional, problemas en aprendizaje, adecuada comprensión, juicio y raciocinio adecuado, inteligencia aparente normal, no restricciones en la locomoción, se muestra colaboradora.

PRUEBAS APLICADAS

Se realizó prueba NEUROPSICOLOGICA Escala de inteligencia de Wscheler para adultos, WAIS – cubos, búsqueda de símbolos, claves, dígitos, dígitos en orden directo, inverso y creciente, Semejanzas, comprensión, información, vocabulario, matrices, aritmética, rompecabezas visuales.

Neuropsi 3: Orientación, atención y concentración, memoria, funciones ejecutivas, escala TDAH.

Cuestionario Check list TDAH		
Criterios DSM 5	A1 Inatento (8) Alterado	A2 Hiperactividad/Impulsividad (2) Normal
Observación: Las puntuaciones superiores en la escala clínica a 5 puntos, son consideradas en riesgo, y una puntuación iguales o superiores a 6 puntos en la escala adaptativa se consideran un criterio de anormalidad		

ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS (WAIS - IV)

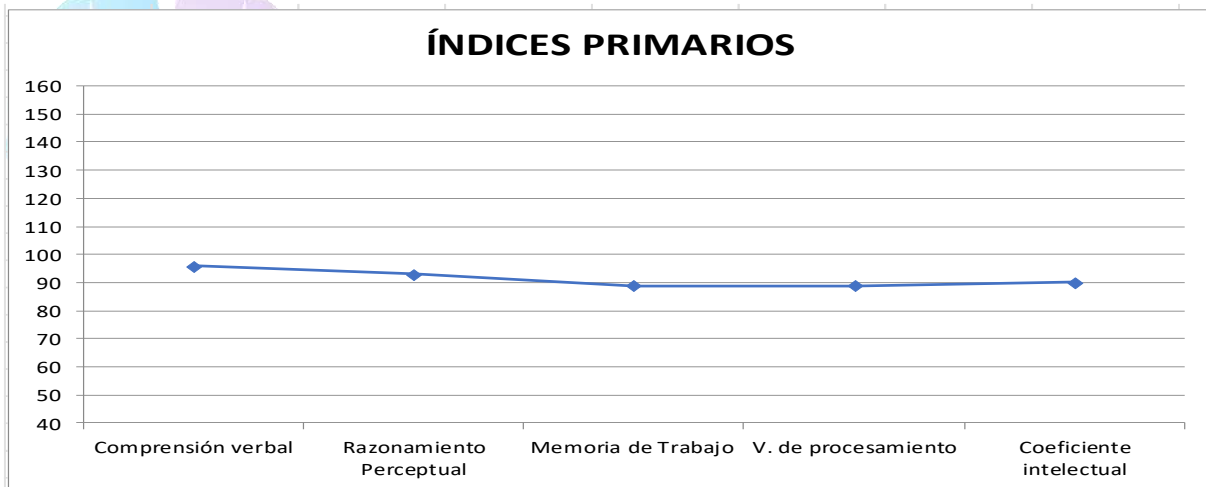
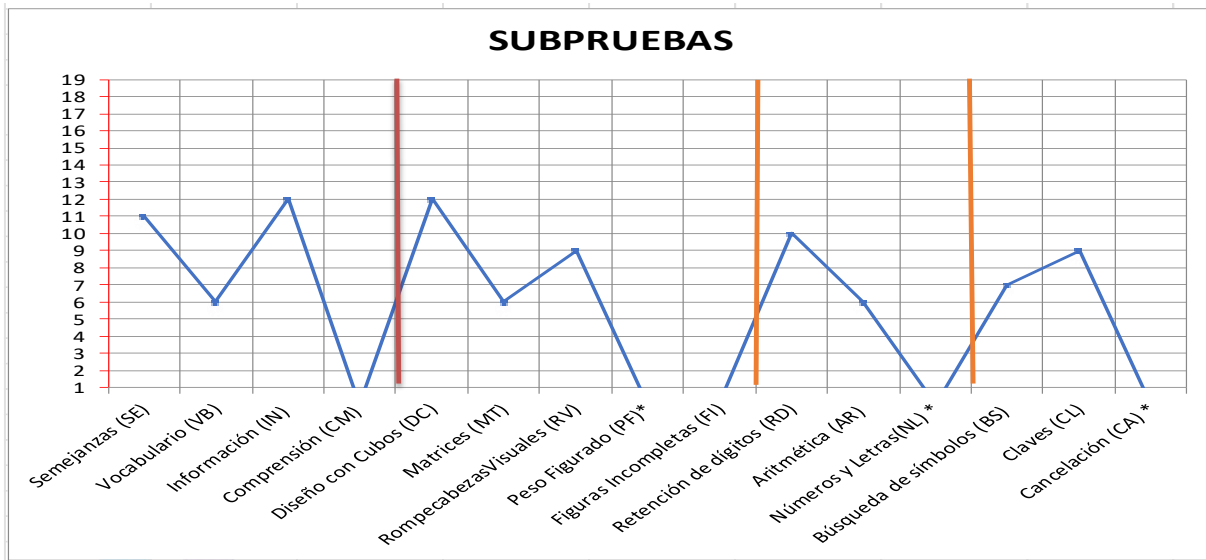
RANGO DE PERCENTILES DE PRUEBA DE INTELIGENCIA

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada



 WAIS-IV [®]																																																																																		
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS® - CUARTA EDICIÓN																																																																																		
Nombre:																																																																																		
Fecha de Aplicación	23/08/2025																																																																																	
Fecha de Nacimiento	26/10/1995																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>Meses</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>9</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	Años	Meses	Días	29	9	28																																																																											
Años	Meses	Días																																																																																
29	9	28																																																																																
Edad Cronológica																																																																																		
ÍNDICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUB-PRUEBA</th> <th>PN</th> <th>PE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Comprensión verbal (ICV)</td> <td>Semejanzas (SE)</td> <td>25</td> <td>11</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Vocabulario (VB)</td> <td>24</td> <td>6</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td>Información (IN)</td> <td>17</td> <td>12</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Razonamiento Perceptual (IRP)</td> <td>Diseño con Cubos (DC)</td> <td>51</td> <td>12</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Matrices (MT)</td> <td>12</td> <td>6</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td>Rompecabezas Visuales (RV)</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Memoria de trabajo (IMT)</td> <td>Retención de dígitos (RD)</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Aritmética (AR)</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Velocidad de Procesamiento (IVP)</td> <td>Claves (CL)</td> <td>62</td> <td>9</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Búsqueda de símbolos (BS)</td> <td>22</td> <td>7</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td rowspan="6"></td> <td>ÍNDICES PRIMARIOS</td> <td>S. de PE</td> <td>PCo</td> <td>DESCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Comprensión verbal</td> <td>29</td> <td>96</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Razonamiento Perceptual</td> <td>27</td> <td>93</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td>Memoria de Trabajo</td> <td>16</td> <td>89</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td>V. de procesamiento</td> <td>16</td> <td>89</td> <td>Medio Bajo</td> </tr> <tr> <td>Coficiente intelectual</td> <td>88</td> <td>90</td> <td>Promedio</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Edad mental aproximada</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SUB-PRUEBA	PN	PE	DESCRIPCIÓN	Comprensión verbal (ICV)	Semejanzas (SE)	25	11	Promedio	Vocabulario (VB)	24	6	Medio Bajo	Información (IN)	17	12	Promedio	Razonamiento Perceptual (IRP)	Diseño con Cubos (DC)	51	12	Promedio	Matrices (MT)	12	6	Medio Bajo	Rompecabezas Visuales (RV)	14	9	Promedio	Memoria de trabajo (IMT)	Retención de dígitos (RD)	25	10	Promedio	Aritmética (AR)	9	6	Medio Bajo	Velocidad de Procesamiento (IVP)	Claves (CL)	62	9	Promedio	Búsqueda de símbolos (BS)	22	7	Medio Bajo		ÍNDICES PRIMARIOS	S. de PE	PCo	DESCRIPCIÓN	Comprensión verbal	29	96	Promedio	Razonamiento Perceptual	27	93	Promedio	Memoria de Trabajo	16	89	Medio Bajo	V. de procesamiento	16	89	Medio Bajo	Coficiente intelectual	88	90	Promedio		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Años	Meses	26	9	Edad mental aproximada	
SUB-PRUEBA	PN	PE	DESCRIPCIÓN																																																																															
Comprensión verbal (ICV)	Semejanzas (SE)	25	11	Promedio																																																																														
	Vocabulario (VB)	24	6	Medio Bajo																																																																														
	Información (IN)	17	12	Promedio																																																																														
Razonamiento Perceptual (IRP)	Diseño con Cubos (DC)	51	12	Promedio																																																																														
	Matrices (MT)	12	6	Medio Bajo																																																																														
	Rompecabezas Visuales (RV)	14	9	Promedio																																																																														
Memoria de trabajo (IMT)	Retención de dígitos (RD)	25	10	Promedio																																																																														
	Aritmética (AR)	9	6	Medio Bajo																																																																														
Velocidad de Procesamiento (IVP)	Claves (CL)	62	9	Promedio																																																																														
	Búsqueda de símbolos (BS)	22	7	Medio Bajo																																																																														
	ÍNDICES PRIMARIOS	S. de PE	PCo	DESCRIPCIÓN																																																																														
	Comprensión verbal	29	96	Promedio																																																																														
	Razonamiento Perceptual	27	93	Promedio																																																																														
	Memoria de Trabajo	16	89	Medio Bajo																																																																														
	V. de procesamiento	16	89	Medio Bajo																																																																														
	Coficiente intelectual	88	90	Promedio																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Años	Meses	26	9																																																																													
Años	Meses																																																																																	
26	9																																																																																	
Edad mental aproximada																																																																																		





La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario, información, aritmética, búsqueda de símbolos). La paciente obtuvo un CIT de **90**, lo que la ubica en un rango dentro del promedio para su edad y nivel escolar, considerando que la puntuación normal o media oscila entre 90 a 109.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **96**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.



Razonamiento visoespacial o perceptivo

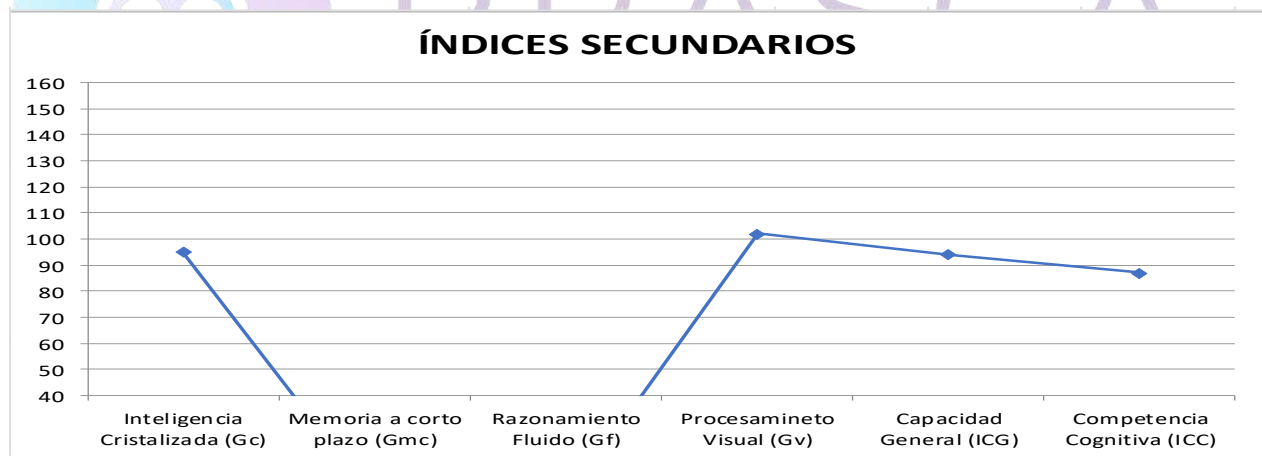
El valor obtenido en RP es de **93**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos constructivos, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **89**, se clasifica con una capacidad general **medio bajo**, estando 1 rango por debajo de lo esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **89**, se clasifica con una capacidad general **medio bajo**, estando 1 rango por debajo de lo esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.



La paciente presenta dificultades en la memoria a corto plazo lo que puede generar dificultades en el aprendizaje significativo, agudizado por fallas atencionales, con un nivel adecuado de razonamiento fluido, habilidad cognitiva esencial que permite adaptarse y resolver los problemas cotidianos, así como hacerle frente a situaciones novedosas, es importante resaltar que este factor se puede ver afectado en los casos que existan afectaciones en el estado de ánimo, toda vez que la motivación juega un papel fundamental, con una capacidad general promedio pero con un desempeño de competencia cognitiva por debajo del promedio esperado, es importante deslucir que El ICG (Índice de competencia cognitiva) proporciona una estimación de la capacidad general, con reducida influencia de la memoria de trabajo y rapidez de procesamiento, mientras que El ICC (Índice de competencia cognitiva), representa las competencias en el procesamiento cognitivo de tareas complejas de nivel superior.



**PERFIL NEUROPSI ATENCIÓN Y MEMORIA**

Nombre y apellido MARIA CAROLINA BARRIOS DAZA
Fecha evaluación 23/08/2025
Fecha nacimiento 26/10/1995
Edad 29 años
Grado escolar Magister
Baremos Baremos Edad: 16 a 30 años, Escolaridad: 10 a 22 años

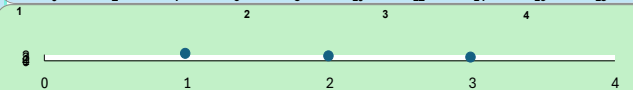
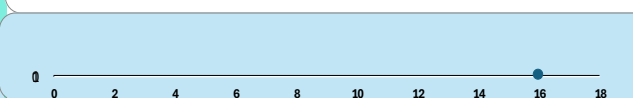
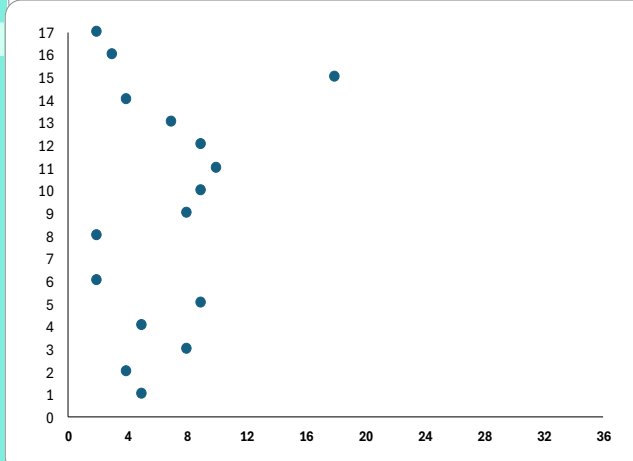
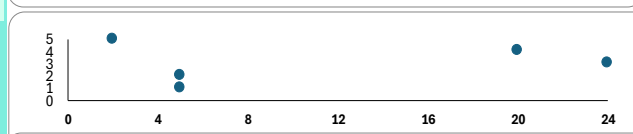
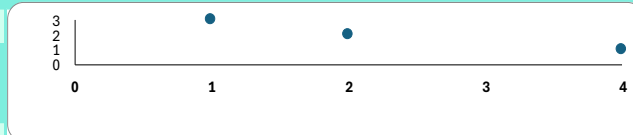
3ª edición

Neuropsi

Atención y Memoria

SubEscala y Puntuación Máxima

ORIENTACIÓN	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada
Tiempo (4)	4	
Espacio	2	
Persona	1	
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada
Retención de dígitos en progresión	5	
Cubos en progresión	5	
Detección visual aciertos	24	
Detección dígitos total	20	
Series sucesivas	2	
MEMORIA	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada
Trabajo. Retención de dígitos en regresión	5	
Trabajo. Cubos en regresión	4	
Codificación. Curva de memoria volumen promedio	8	
Codificación. Pares asociados volumen promedio	5	
Codificación. Memoria lógica promedio historias	9	
Codificación. Memoria lógica promedio temas	2	
Codificación. Figura Semicompleja / Rey-Osterreith	44	
Codificación. Caras	2	
Evocación. Memoria verbal espontánea	8	
Evocación. Memoria verbal por claves total	9	
Evocación. Memoria verbal reconocimiento total	10	
Evocación. Pares asociados total	9	
Evocación. Memoria lógica promedio historias	7	
Evocación. Memoria lógica promedio temas	4	
Evocación. Figura semicompleja / Rey-Osterreith	18	
Evocación. Nombres	3	
Evocación. Reconocimiento total de caras	2	
FUNCIONES EJECUTIVAS	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada
Formación de categorías	16	
Fluidez verbal semántica (reclasificada)	21	3
Fluidez verbal fonológica (reclasificada)	11	2
Fluidez no verbal total (reclasificada)	2	1
Funciones motoras total	17	
Stroop puntuación interferencia (reclasificada)	31	1
Stroop aciertos interferencia (reclasificada)	1	1
PUNTUACIONES TOTALES	Puntuación Natural	Puntuación Normalizada
Total atención y funciones ejecutivas	104	100
Total memoria	149	81
Total atención y memoria	253	86

GRAFICO ASOCIADO A PUNTAJE NORMALIZADA

Paciente con adecuada orientación auto y alopsíquica, con dificultades atencionales en retención de dígitos en progresión y regresión, con algunas dificultades leves en la realización de series sucesivas, con disminución del volumen de vocación lo que puede afectar los procesos de codificación, decodificación y evocación, mejorando las respuestas a partir de la repetición de ejercicios y el uso de claves semánticas y fonológicas, acompañado de problemas ejecutivos en la planificación, seguimiento de secuencia, control atencional, flexibilidad que no afectaron la puntuación general del indicador pero que si puede afectar el desempeño en tareas con un alto grado de complejidad superior relacionados con un alto esfuerzo, mantenimiento de la tarea, concentración y recuperación de la información.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Resultados de evaluación:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva, con tendencia a la distractibilidad pero relacionada con temas del biorritmo, por momentos puede incluso llegar hasta la hipoprosexia.

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos aunque con errores de tendencia perseverativa, con dificultades en la velocidad de procesamiento, en el procesamiento y ejecución de tareas que se deben realizar en un tiempo específico.

Paciente con inadecuada capacidad de esfuerzo en la ejecución de tareas no motivantes, le cuesta prestar atención a los detalles, por momentos se esfuerza y dirige la conducta, inhibiendo los estímulos irrelevantes pero no de forma contingente o constante; le cuesta regular su comportamiento, mantener una adecuada posición sedente, con algo de agitación motora, impulsividad y bajo control atencional.

MEMORIA: Presenta adecuados canales sensorial que incluyen la memoria ecoica e icónica, la memoria de trabajo presenta un desempeño anormal no acorde a lo esperado para la edad y escolaridad. Esto quiere decir, que existe inadecuada capacidad para mantener una información en línea, acorto plazo de forma simbólica, en ocasiones pierde la información suministrada.

Se observo debilidades en la memoria a corto plazo, lo cual se agudiza por falas atencionales y motivacionales, con mayor fortaleza en la evocación de información visual – manipulativa que verbal, necesitando mas repeticiones de lo habitual para lograr un aprendizaje significativo.

Su capacidad de memoria o spam es de 8 sobre 12, observándose de forma incorrecta el efecto de primacia y recencia, se observaron intrusiones, no se observó perseveración, con adecuada organización serial.



LENGUAJE: Existe adecuada capacidad semántica, de fluidez semántica y fonológica, adecuada información y abstracción, con debilidades en el vocabulario, existe adecuado seguimiento de instrucciones complejas ejecutivas, a nivel general existe adecuada capacidad comprensiva, de análisis, síntesis, razonamiento, sin embargo el estado de ánimo puede afectar el curso del lenguaje sobre todo en la labilidad emocional.

No se observaron problemas articulatorios, nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

Fluidez fonológica y semántica: Adecuada habilidad para nombrar la mayor cantidad de palabras posibles que empiezan por un sonido o categoría, estableciendo adecuada capacidad para el acceso y la recuperación de información almacenada en la memoria semántica.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

Es importante citar que durante la realización de las tareas se observó inadecuada pinza trípode, lo cual significa que posiblemente existió un inadecuado proceso madurativo en el neurodesarrollo de lo cual quedan rezagos.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Descripción clínica) Cribada con inadecuada autorregulación, le cuesta generar estrategias para la resolución de problemas, le cuesta ser flexible, tiende a tener respuestas perseverativas, le cuesta en ocasiones organizarse, seguir una secuencia y planificar una acción, a veces le cuesta reconocer la falta, justifica la acción, le cuesta mantener la atención de forma prolongada, baja motivación, biorritmo bajo, tendencia a perder el control, tendencia a estar en crisis con labilidad emocional que afecta el desempeño en las tareas, se observó adecuada fluidez verbal con bajas respuestas en la memoria de trabajo.

Paciente con **CIT de 90**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WAIS IV con **capacidad general intelectual promedia**, sin embargo, las bajas puntuaciones en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, memoria a corto plazo, aprendizaje, alteraciones emocionales, establecen la necesidad de intervención y rehabilitación teniendo en cuenta que esto puede afectar el desempeño personal, laboral, familiar y social.

Se observa adecuado desarrollo de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 96 y habilidades visoespaciales de 93, lo cual establece un adecuado desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.

La memoria de trabajo, 89 y velocidad de procesamiento, 89, se encuentran por debajo del promedio, con punto crítico, pudiendo generar dificultades en el manejo de la información a corto, plazo, en línea, rápida, efectiva y sin interferencia, lo que puede generar dificultades



en la adquisición del aprendizaje, punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

Perfil de la paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de capacidad intelectual promedia, acompañado de perfil perturbación de la actividad y la atención o TDAH tipo inatento de gravedad moderada, con signos y síntomas claros de depresión acompaña de episodios ansiosos, con mayor predominio depresivo (para esta nosología no se aplico escala teniendo en cuenta la gravedad de los signos y síntomas clínicos – bradilalia, bradipsiquia, labilidad emocional, pensamiento catastrófico y dicotómico, ideas irracionales, distorsiones cognitivas, visión de negativa de si misma, de los demás y del futuro, desesperanza aprendida, sentimientos de inferioridad, desvalorización de sus capacidades que debe ser objeto de atención clínica por psicología y psiquiatría).

Se observo adecuada comprensión verbal, razonamiento viso espacial, fluido, adecuada fluidez fonológica y semántica, adecuada orientación auto y alopsíquica, adecuadas praxias aunque con inadecuada pinza trípode que se relaciona con un proceso de inmadurez en los procesos de neurodesarrollo del cual se desconocen detalles, la paciente presenta baja competencia cognitiva para tareas de alta complejidad, fallas atencionales (con tendencia a la distractibilidad e hipoprosia), baja motivación, bajo control atencional, le cuesta adaptarse de forma efectiva, le cuesta planificar, seguir secuencia, organizar su conducta, comete errores perseverativos, con una alta capacidad de concienciación de los errores lo que le ayuda a modificar algunas respuestas en el camino, tarda mucho mas de lo esperado en procesar y ejecutar una tarea, le cuesta mantener y procesar información en línea de forma simbólica, pierde la información, se fatiga con facilidad, le cuesta mantenerse atenta o concentrada por periodos largos de tiempo, tendencia a la procrastinación, se debe mejorar la respuestas de alto nivel cognitivo, en ocasiones no verifica la tarea, busca la estrategia para hacerla más rápido pero en ocasiones de forma poca eficiente, la calidad de las tareas pueden variar y se relacionan con su estado de ánimo, juicio y raciocinio desviado, fatiga cognitiva, necesita de varias repeticiones para mejorar la capacidad de memoria a corto plazo y aprendizaje, en ocasiones la autopercepción de sus capacidades limitan un mayor desempeño en el desarrollo de las tareas, existe en ocasiones una forma de autosabotaje de lo que ha logrado a nivel intelectual minimizando sus esfuerzos y capacidades pudiendo afectar el desempeño laboral, social, familiar, personal.



IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

CIE 11 – 6A05: TRASTORNO POR HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE LA ATENCIÓN.

6A05.0: TDAH, predominantemente con presentación de falta de atención, con afectación del estado de ánimo (ansiedad y depresión).

TDAH CIE 10: F900 *PERTURBACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCIÓN* (equivalente a TDAH tipo inatento o falta de atención).

CIT DE 90, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL PROMEDIA, con necesidad de apoyo, supervisión.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología tres meses.

Rehabilitación cognitiva 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos de atención sostenida, mantenimiento en la tarea, motivación, metacognición, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, memoria y aprendizaje.

Rehabilitación por psicología clínica para abordar signos y síntomas ansiosos depresivos, ejecutivos, problemas de autoestima, distorsiones cognitivas, triada cognitiva, labilidad emocional, bradilalia, bradipsiquia habilidades sociales, de afrontamiento, auto eficacia y autodeterminación.

Recomendaciones generales:

Usa rutas de trabajo claras: listas de tareas diarias, un horario fijo y bloques de tiempo para cada actividad.

Divide tareas grandes en sub-tareas manejables con plazos pequeños y criterios de finalización.

Emplea recordatorios visuales: pizarras, listas de verificación, colores para priorizar.

Revisa y ajusta al inicio de cada día la agenda y las prioridades.

Aplica rutinas repetibles: empezar con una tarea de baja fricción para activar la productividad.

Usa plantillas o checklists para procesos recurrentes (ej., informes, presentaciones).

Establece una regla “solo una tarea a la vez” para evitar multito-do.

Entorno de trabajo: señalar con “no molestar” o ruido blanco; elimina estímulos irrelevantes.



Practica autoafirmaciones positivas y registro de logros diarios (pequeños avances cuentan).

Programa pausas para regular emociones: respiración, mini-medidas de mindfulness, caminatas cortas.

Reestructura pensamientos automáticos: cuestiona ideas como “no voy a poder” con evidencia real de progresos.

Anota dudas o bloqueos para abordarlas en un momento específico (no durante la tarea).

Usa herramientas externas para la memoria de trabajo: notas, calendarios, grabaciones con presencia de tareas.

Desarrolla un plan de contingencia para fallos: qué hacer si te atrasas, quién puede apoyar, cuándo pedir ayuda.

Prioriza con métodos simples (Lo importante/urgente).

Asigna tiempos estimados a cada tarea y revisa desviaciones al cierre del día.

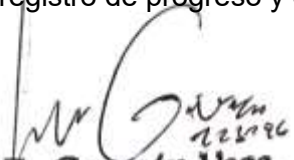
Considera límites razonables de carga laboral y acuerda con supervisión ajustes cuando sea necesario.

Buscar ajustes razonables: entorno silencioso, mayor tiempo para entregas, instrucciones por escrito, feedback más frecuente.

Establece un plan de apoyo con un supervisor o mentor para revisión de progreso.

Fomenta una comunicación honesta sobre necesidades y recursos.

Revisa semanalmente qué estrategias funcionan y cuáles no; ajusta herramientas y rutinas. Mantén un registro de progreso y de desafíos para detectar patrones y áreas de mejora.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional:123096

